Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 20ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:( )

Processo nº 0046429-85.2023.8.17.2001

AUTOR(A): THALES PAULO DE OLIVEIRA

RÉU: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

SENTENÇA

Vistos, etc ...

THALES PAULO DE OLIVEIRA, devidamente qualificado e por intermédio de Advogado a tanto constituído, manejou a presente ***AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL*** em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED, pessoa jurídica de direito privado, igualmente identificada nos autos.

Pugnou, inicialmente, pela concessão da gratuidade da justiça.

Argumentou ter sido diagnosticado com LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA, sendo-lhe prescrito o medicamento SPRYCEL DASATINIBE 100 mg, que já vem sendo fornecido pela parte demandada, todavia, referenciada parte vem opondo embaraços.

Pontuou que a demandada NEGOU a autorização e solicitou outros documentos e exames para a continuação do medicamento SPRYCEL.

Por fim, pugnou pela reparação por danos morais.

Em sede de tutela de urgência, requereu a demandada fosse compelida a arcar com as despesas do tratamento solicitado pelo médico assistente do Autor, qual seja, TRATAMENTO ONCOLÓGICO COM SPRYCEL dasatinibe 100 mg, uso contínuo, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária.

Atribuiu à causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Deferiu-se a tutela de urgência antecipando o direito material pretendido pela parte demandante (id 131652383).

Citada, a suplicada apresentou **Contestação** (id. 139011759), por intermédio da qual, em sede de preliminar, suscitou ausência de condições de ação, ante a falta de interesse de agir, tendo em vista a perda superveniente do objeto. A demandada alega que desconhece qualquer negativa ao fornecimento do medicamento.

No mérito, destacou a ausência da juntada de documento, por parte do autor, que comprove a negativa da operadora em fornecer o medicamento requestado.

Rechaçou o pleito indenizatório.

Houve apresentação de Réplica (id. 150948187).

As partes declinaram da possibilidade de produção de novas provas (id. 154704048 e id. 155176886).

É o relatório. Decido.

O feito se apresenta suficientemente instruído e comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, por não ser necessária a produção probatória.

Antes de adentrarmos ao mérito da causa, faz-se necessário o enfrentamento da preliminar suscitada no bojo da peça contestatória.

O demandado arguiu ausência de condições de ação, ante a falta de interesse de agir, tendo em vista a perda superveniente do objeto. A demandada alega que desconhece qualquer negativa ao fornecimento do medicamento.

Foi decidido (id. 131652383) que "não obstante o laudo da médica assistente (datado no mês em curso – abril 2023), direcionada à Central Nacional Unimed, a considerar as conversas com o plano de saúde demandado, via ferramenta WhatsApp, iniciadas no dia 03 de abril do ano em curso (Id 131603654), com elas busca o autor a liberação de novo lote do medicamento de uso continuo, e após encaminhar a prescrição médica, tais conversas evoluíram até o dia 19 de abril, quando **o plano de saúde por prepostos seus, informa que a solicitação encontra-se com pendencias de exames com laudo complementar, anatomopatológico, imunofenotipagem e relatório médico descrevendo tratamentos anteriores e hemograma atualizado**".

A decisão que concedeu a tutela de urgência também esclareceu que "não se mostra razoável condicionar a liberação do medicamento já utilizado pelo paciente, prescrito por médica assistente, a exames outros, quando a médica assistente, em sua prescrição faz saber da necessidade de liberação, sem tais exames, sob pela de regressão no tratamento com a recaída da doença".

Desse modo, resta configurada a negativa tácita da operadora de plano de saúde em fornecer o medicamento, vez que impôs inúmeros embaraços ao fornecimento do fármaco, condicionando a liberação do medicamento à realização de outros exames.

Por conseguinte, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.

Passemos à análise do mérito da causa.

Cumpre destacar, inicialmente, que os contratos de seguro, por definição legal, encerram relação de consumo, portanto devem ser interpretados sob a ótica da legislação que lhes é própria, ainda que definidos ou regulamentados em textos outros. Tal entendimento foi ratificado por meio do enunciado da Súmula nº 608, do STJ: "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

Há, desta forma, que se analisar o contrato firmado entre as partes e verificar a validade das cláusulas estabelecidas, as quais devem estar em total observância às regras previstas no microssistema consumerista, sob pena de serem consideradas nulas de pleno direito.

Nos presentes autos discute-se se a negativa de cobertura perpetrada pela operadora de plano de saúde demandada foi efetuada de forma ilícita, bem como se houve dano moral decorrente da resistência ao custeio do tratamento médico prescrito.

Ora, quando da análise da preliminar de mérito, restou caracterizada a negativa, por parte do plano de saúde, em fornecer o medicamento, pois passou a exigir exames complementares. Observe-se:

"não obstante o laudo da médica assistente (datado no mês em curso – abril 2023), direcionada à Central Nacional Unimed, a considerar as conversas com o plano de saúde demandado, via ferramenta WhatsApp, iniciadas no dia 03 de abril do ano em curso (Id 131603654), com elas busca o autor a liberação de novo lote do medicamento de uso continuo, e após encaminhar a prescrição médica, tais conversas

evoluíram até o dia 19 de abril, quando o plano de saúde por prepostos seus, informa que a solicitação encontra-se com pendencias de exames com laudo complementar, anatomopatológico, imunofenotipagem e relatório médico descrevendo tratamentos anteriores e hemograma atualizado".

Não se mostra razoável a recusa de atendimento efetuada pela seguradora, ao impor ao consumidor, como condicionante ao fornecimento do fármaco, a obrigação de apresentar inúmeros exames complementares, mesmo porque o medicamento já vinha sendo ministrado. Esclareça-se, inclusive, o laudo médico atesta a real necessidade de se utilizar o fármaco prescrito. Sendo assim, não cabe à seguradora substituir-se aos profissionais da saúde para definir se a prescrição médica é a mais adequada ao caso, notadamente em hipóteses específicas e peculiares como a que ora encontra-se submetida ao crivo desse julgador.

Do mesmo modo, o rol de procedimentos estipulado pela ANS se trata de apontamento exemplificativo, inapto a limitar o procedimento/tratamento que o caso concreto exige.

É importante deixar registrado que, a pacificação de anterior divergência jurisprudencial, firmada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo (EREsp 1.886.929-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/06/2022), foi superada pela superveniente edição da Lei 14.454/2022, que deu nova redação ao art. 10º, §13 da Lei nº 9.656 e consolidou o caráter exemplificativo no rol da ANS. Com a nova redação, o referenciado dispositivo passou a prever:

> "*(...)*
>
> *§13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)*
>
> *I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)*
>
> *II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais*".

Daí, constatado o *overrruling* a respeito do tema, não ampara a Defesa a tese de que o rol da ANS é taxativo. Portanto, deve ser dado primazia ao tratamento sugerido pelo médico assistente, sobretudo porque há efetiva indicação de eficácia e prescrição médica específica a respeito. Ainda que os argumentos acima não fossem suficientes, registro que foi esclarecida a impossibilidade de outros meios de tratamento em razão da condição de saúde da paciente e a ré nem mesmo apresentou substituto terapêutico.

O Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo vem reconhecendo a obrigatoriedade de cobertura do tratamento em comento:

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura dos medicamentos **SPRYCEL 20mg e SPRYCEL 100mg**, associados a **DESATINIBE**, a paciente portadora de leucemia linfoblástica aguda, por não constar em DUT ou rol da ANS – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – Entendimento sumulado por este Tribunal (Súmulas nºs 96 e 102) – **Limitação abusiva, nos termos dos Códigos Civil e de Defesa do Consumidor – Recusa com base em taxatividade do rol da ANS – Afastamento, especialmente considerado o advento da Lei nº 14.454/2022** – Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10312566920228260002 São Paulo, Relator: Alvaro Passos, Data de Julgamento: 31/10/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

Ademais, é suficiente dizer que a bula do medicamento, registrada perante a ANVISA, explicita as seguintes indicações:

O SPRYCEL é um medicamento de prescrição médica usado para tratar adultos com:

- Leucemia Mieloide Crônica Cromossomo Philadelphia-positivo (LMC Ph+) na fase crônica recém diagnosticada.

- Leucemia Mieloide Crônica Cromossomo Philadelphia-positivo (LMC Ph+), que não estão mais se beneficiando com, ou têm intolerância à terapia anterior incluindo mesilato de imatinibe.

- Leucemia Linfoblástica Aguda Cromossomo Philadelphia-positivo (LLA Ph+), que não estão mais se beneficiando com, ou têm intolerância à terapia anterior.

A bula continua afirmando que "O princípio ativo do SPRYCEL é o dasatinibe. O dasatinibe age reduzindo a atividade das proteínas dentro das células leucêmicas de pacientes adultos com Leucemia Mieloide Crônica Cromossomo Philadelphiapositivo (LMC Ph+) ou Leucemia Linfoblástica Aguda Cromossomo Philadelphia-positivo (LLA Ph+). Essas proteínas são responsáveis pelo crescimento descontrolado das células da leucemia. Ao inibir essas proteínas, o SPRYCEL mata as células leucêmicas na medula óssea e permite que a produção normal de células vermelhas, brancas e plaquetas seja retomada.

Como se pode observar das transcrições acima, mesmo aos olhos do leigo, há aproximação entre a situação fática enfrentada pela paciente e a indicação terapêutica prescrita pelo médico assistente.

Conforme laudo médico constante no documento de ID 131603653, a paciente foi diagnosticada com **LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA**.

Ora, entendo que a defesa não foi suficientemente robusta para convencer de que a indicação médica não se encaixa ordinariamente nas indicações da bula, em especial as passagens acima destacadas em negrito.

A controvérsia reside no subjetivismo do diagnóstico, quando o médico assistente do autor entende que a situação fática se enquadra naquela em que há indicação do medicamento, enquanto o plano de saúde alega ser uso fora das prescrições da bula. Sob este aspecto, percebo mais divergência de diagnóstico, ou seja, do estado de saúde e extensão do dano do paciente do que qualquer debate apto acerca de tratamento tido como experimental.

O diagnóstico do médico assistente da autora leva a conclusão inevitável de que a ré não apresentou fundamentação robusta e não produziu prova de que dito quadro descrito pelo médico do autor não se enquadra naquele indicado em bula registrada na ANVISA.

Portanto, revela-se injusta a negativa de cobertura perpetrada pelo plano de saúde, prosperando o pleito alusivo à obrigação de fazer de a demandada de custear o tratamento indicado pelo médico assistente do autor.

Registre-se também que somente o médico detém a atribuição de avaliar e escolher a melhor alternativa de tratamento, que melhor convém à cura do paciente. Entender de modo diverso põe em risco a vida do consumidor.

A seguradora não poderia se valer de cláusula notoriamente desfavorável ao segurado para furtar-se da responsabilidade pela cobertura do procedimento encetado. Panorama no qual é lícito concluir que, da forma como elaboradas, as cláusulas delimitadoras de garantia e de cobertura de exames e procedimentos são nulas por gerarem considerável desequilíbrio contratual. Este tem sido o caminho eleito pelos nossos Tribunais:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.CARCINOMA DE UROTÉLIO TRANSICIONAL, COM METÁSTASES PARA LINFONODOS EM HILO HEPÁTICO E PRÓXIMOS A VEIA RENAL ESQUERDA. TERAPIA MEDICAMENTOSA COM **PEMBROLIZUMABE**. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO SIMILARMENTE EFICAZ E SEGURO INCORPORADO AO ROL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRECEDENTE DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO NA INSTÂNCIA INFERIOR. (...) **3. Hipótese em que, embora não tenha sido incorporado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (RN 465/2021 e suas alterações), é certo que o (PEMBROLIZUMABE) tem registro Na ANVISA (Registro ANVISA nº 1017102090017) e tem indicação em bula para o tratamento de diversos tipos de câncer, inclusive para o tratamento de carcinoma**

urotelial localmente avançado ou metastático que acomete a autora. 4. Havendo comprovação da eficácia do procedimento à luz da medicina baseada em evidências, e não tendo a operadora de saúde indicado a existência de outro procedimento, de cobertura obrigatória, que seja eficaz, efetivo e seguro, capaz de atingir o mesmo resultado almejado, o procedimento indicado pelo médico assistente deve ser coberto mesmo fora das hipóteses das diretrizes de utilização do rol de procedimentos e eventos em saúde. Precedente do STJ. 5. Malgrado as diretrizes da ANS sirvam de parâmetro para a atuação médica, não podem se sobrepor à prescrição do profissional que assiste pessoal e diretamente o paciente, notadamente quando a requisição está devidamente justificada. 6. A negativa de cobertura para terapia medicamentosa destinada a tratamento de neoplasia maligna, doença de notória gravidade, faz surgir o dano moral indenizável por potencializar a angústia experimentada pelo paciente. 7. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Apelação e recurso adesivo a que se nega provimento. (TJPE - APELAÇÃO CÍVEL 0076153-42.2020.8.17.2001, Rel. FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC), julgado em 19/09/2022, DJe)

APELAÇÃO CÍVEL. CPC/1973. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DA OPERADORA EM FORNECER MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER - SPRYCEL/DESATINIBE PRESCRITO PELO MÉDICO SOB O ARGUMENTO DE QUE SE TRATA DE MEDICAMENTO EXPERIMENTAL, QUE NÃO TEM PREVISÃO CONTRATUAL, E QUE A ADMINISTRAÇÃO DO MESMO É DOMICILIAR. AUTOR PORTADOR DE ADENOCARCINOMA DE PULMÃO COM MÚLTIPLAS METÁSTASES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMANDO A DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA, CONDENANDO A SEGURADORA RÉ A CUSTEAR O TRATAMENTO DO QUAL NECESSITA O AUTOR, COM O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO SPRYCEL (DESATINIBE) E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. A AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA NÃO CARACTERIZA, POR SI SÓ, OBSTÁCULO AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO, CABENDO AO MÉDICO ASSISTENTE A ESCOLHA DAQUELE A SER EMPREGADO NO TRATAMENTO. AUTOR SEM OPÇÕES DE QUIMIOTERAPIA CONVENCIONAL. VERBETE SUMULAR ETJ Nº 340. SE EXISTE COBERTURA PARA A DOENÇA, NÃO SE PODE COGITAR DA EXCLUSÃO DE MECANISMOS ELEITOS PELOS MÉDICOS PARA O SUCESSO DE INTERVENÇÃO. COMPENSATÓRIA BEM FIXADA E QUE MERECE SER MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. (TJ-RJ - APL: 00247518720168190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 40 VARA CIVEL, Relator: WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 26/04/2017, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 28/04/2017)

Por fim, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, este também merece guarida.

Conquanto o mero descumprimento contratual não gere, em regra, danos morais, o caso dos autos demonstra merecer tratamento diferenciado. A parte autora estava em situação de fragilidade emocional e física, posto que estava acometida de doença grave, necessitando submeter-se ao tratamento com urgência.

Suportando o autor não só o sofrimento físico, mas, também, a angústia de moléstia grave, cujo tratamento a ré negou-se a custear, resta claro que seu abalo psicológico com a não cobertura do medicamento não se limitou a mero aborrecimento. Insofismável, no caso sob apreço, o dano moral que sofreu a demandante.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a violação a direitos da personalidade, a exemplo dos direitos à saúde e à vida, caracteriza, por si só, o dano moral, não sendo necessária sequer a ocorrência de reação psíquica da vítima, como os sentimentos de dor, vexame, sofrimento etc (STJ, 4ª Turma, REsp 1.245.550-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/3/2015).

Assim, o dano moral resta configurado, por ter a empresa demandada agido em desrespeito aos mais preciosos bens de um indivíduo, que são sua vida, saúde e dignidade. O entendimento é esposado pelo STJ, a exemplo do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DOMICILIAR. C NCER EM FASE METASTÁTICA. RECUSA INADMISSÍVEL POR PARTE DA OPERADORA. CLÁUSULA MANIFESTAMENTE ABUSIVA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO A PERPASSAR POR NORMAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 126/STJ. DANOS MORAIS. PLENO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO NA ORIGEM.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é inadmissível a recusa de cobertura de tratamento domiciliar pelo plano de saúde, aqui compreendendo-se o fornecimento, em âmbito domiciliar, de fármaco voltado a estender a sobrevida de paciente com câncer em fase metástica. Atração do enunciado 126/STJ a corroborar a negativa de seguimento do recurso da operadora de saúde.

2. Verificada ofensa clara a direitos da personalidade, deve ser reconhecida a existência de dano moral, que dispensa prova, por sua natureza de dano "in re ipsa".

3. Desnecessária a realização de laudo psicológico a atestar o real e profundo arrebatamento de pessoa que, tangenciando o falecimento, vê negada a administração domiciliar de medicamento voltado à inibição da evolução da doença.

4. Valor da indenização fixado, com base em precedentes da quase totalidade dos integrantes da Colenda Segunda Seção, em R$ 10.000, 00.

5. Revelam-se diminutos os honorários arbitrados em R$ 900,00 para causa de relativa complexidade e razoável duração, abrindo-se a via corretiva desta Corte Superior.

6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no REsp 1541966/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015)

Outrossim:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COBERTURA FINANCEIRA DE TRATAMENTO MÉDICO) E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO RECLAMO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes. 2. O óbice insculpido na Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com amparo na alínea "c" do permissivo constitucional, sendo também aplicável aos reclamos fundados na alínea "a", uma vez que a expressão "divergência", referida no citado verbete sumular, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional. 3. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 430.208/CE (2013/0376246-1), 4ª Turma do STJ, Rel. Marco Buzzi. j. 20.03.2014, unânime, DJe 09.04.2014).

Suficientemente demonstrado o dano de índole moral, resta fixar o valor da indenização devida, o que faço levando em consideração a gravidade do fato em si, a extensão do dano sofrido, o desgaste emocional suportado pela parte autora, nos termos do art. 944 do CC, razão por que arbitro a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Posto isto, com arrimo nos fundamentos fáticos e jurídicos ora explicitados, resolvo JULGAR PROCEDENTE a pretensão entabulada, para confirmar a antecipação de tutela concedida initio litis e condenar a demandada a autorizar/custear/fornecer o medicamento SPRYCEL DASATINIBE 100 mg, conforme prescrição médica.

Ainda, resolvo condenar a demandada à indenização por danos morais, arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia esta a ser corrigida monetariamente pela tabela Encoge, a partir da data desta sentença (Súmula n°362 do STJ), e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, tudo até o efetivo pagamento;

Extingo o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, além dos honorários advocatícios, à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação indenizatória, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, acrescido de R$ 1.000,00 (hum mil reais) no tocante à condenação na obrigação de fazer (alínea “a”), por ter valor inestimável (art. 85, § 8º, CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em caso de interposição de recurso de embargos de declaração, intime-se a parte embargada, para que, querendo, apresente contraditório no prazo de 5 (cinco) dias, retornando os autos conclusos após decurso do prazo.

Para a hipótese de ser apresentado recurso de apelação, proceda-se a intimação da parte recorrida para que apresente contrarrazões, querendo, no prazo de 15 dias. Encerrado dito prazo, remeta-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Após o trânsito em julgado, verificada a inércia da parte interessada, arquivem-se independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

Recife, 16 de janeiro de 2024.

Ossamu Eber Narita

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: OSSAMU EBER NARITA
19/01/2024 11:08:22
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 158014744

24011911082231900000154346831

IMPRIMIR GERAR PDF